מספר פנימי:

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים:

_____

הצעת חוק: זכות החולה להסכמה מודעת להחלפת תרופה ולשמירה על רצף טיפולי (תיקוני חקיקה) התשפ"ו-2026

מטרה	1.	תיקון חוק זה נועד להבטיח לציבור המטופלים בישראל טיפול מיטבי על בסיס הסכמה מדעת לטיפול ובחינה מדעית של השלכות טיפול הנשען על הנחת זהות ההשפעה של בין תרופות בעלות הרכב כימי וזמינות ביולוגית דומים, ולוודא כי הבחירה, הצורך הטיפולי והשמירה על הרצף הטיפולי יהוו שיקול מרכזי ומכריע במתן הטיפול.
תיקון סעיף ההגדרות *בפקודת הרוקחים*	2.	במקום ההגדרה "תכשיר רשום" בסעיף 1 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א-1981 יבוא: "תכשיר רשום" - תכשיר הרשום בפנקס תחת שם מסחרי ייחודי, בנוסף לשמו המדעי של החומר הפעיל בו, אשר רישומו תקף;
הוספת הגדרות לפקודת הרוקחים	3.	בסוף סעיף 1 לפקודת הרוקחים יבוא: "תרופת מקור" - תכשיר רפואי שנרשם לראשונה בפנקס התכשירים על בסיס תיק נתונים מחקרי מלא, הכולל הוכחות עצמאיות לבטיחותו וליעילותו והמהווה נקודת ייחוס לאישור תכשירים זהים. "תכשיר זהה" - תכשיר שהוא זהה לתכשיר הרשום בפנקס התכשירים כתרופת מקור: בחומר הפעיל שבו, בצורתו, בחוזקו באופן לקיחתו, בפעילותו הרפואית, ובזמינותו הביולוגית, ואשר אושר בידי מינהל המזון והתרופות של ארצות הברית של אמריקה לשיווק שם, או בידי הרשות המוסמכת של האיחוד האירופי לשיווק בארצות האיחוד. "זמינות ביולוגית" - מדידת הריכוזים של החומר הפעיל בדם, כפונקציה של זמן. "תכשיר מרשם גנרי" - תכשיר מרשם שרישומו נעשה על בסיס היותו

		תכשיר זהה לתכשיר מרשם הרשום בפנקס כתרופת מקור.
תיקון סעיף 27(א) לפקודת הרוקחים	4.	בסעיף 27 (א) לפקודת הרוקחים, אחרי "ובכלל זה" יבוא: "לא ינפק אלא את התכשיר הרשום במרשם, לפי השם המסחרי הנקוב בו. לא נקב המרשם בשם מסחרי, ינפק את רוקח את תרופת המקור הרשומה בשמו המדעי של התכשיר, או תכשיר תואם שניתן אישור לייבאו לפי סעיף 47ג לחוק זה"
מחיקת סעיף 27 (ב) לפקודת הרוקחים	5.	סעיף 27 (ב) ימחק.
תוספת לסעיף 47א(א1) לפקודת הרוקחים	6.	בסוף סעיף 47א(א1) לפקודת הרוקחים יבוא: "עבור תכשיר שקבע המנהל שהוא תכשיר מרשם, ירשם שם מסחרי שיבדיל את התכשיר מתכשירים זהים לו כהגדרתם לפי סעיף 1 לפקודה, ויציין במפורש אם מדובר בתרופת מקור או תכשיר מרשם גנרי כהגדרתם בסעיף 1 לחוק זה".
תיקון סעיף 47א (א2) (1) לפקודת הרוקחים	7.	סעיף 47א(א2) (1) לפקודה ימחק ובמקומו יבוא: "(1) לצורך רישום של תכשיר זהה, כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה, די בהוכחת קיומו של אישור כאמור כדי לרשום את התכשיר בפנקס התכשירים על פי תנאי הרישום שקבעו הרשויות האמורות ולתקופה שקבעו ובלבד שיצויין בשם מסחרי נבדל מזה של התכשיר הרשום ויזוהה בפנקס כתכשיר מרשם גנרי"
תיקון סעיף 47א (א2) (2) לפקודת הרוקחים	8.	סעיף 47א(א2) (1) לפקודה ימחק ובמקומו יבוא: "(2) הוגשה בקשה לרישום תכשיר בפנקס והוכח למנהל כי התכשיר עומד בתנאים לתכשיר זהה לפי סעיף 1 לפקודה זו, ירשום המנהל את התכשיר בפנקס בתוך 70 ימים ממועד הגשת הבקשה, אלא אם כן נתן הודעה מנומקת מדעית וניתנת לתיקוף חיצוני, בתוך התקופה האמורה על סירוב לרשום את התכשיר;
תוספת לסעיף 8(א1)(ד) לחוק בריאות ממלכתי	9.	בסוף סעיף 8(א1) לחוק בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994 יבוא: (ד) הנחה ממחיר תרופה קיים כדי לעודד מטופלים להחליף תכשיר ייחוס בתכשיר רשום גנרי כהגדרתו בפקודת הרוקחים.
תוספת סעיף 21ה לחוק בריאות ממלכתי	10.	אחרי סעיף 21ד לחוק בריאות ממלכתי יבוא: "הבטחת רצף טיפולי וטיפול מבוסס ראיות
הגדרות		(א) בסעיף זה:

			"תכשיר הייחוס" - תכשיר מרשם כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א-1981, בשמו המסחרי הייחודי, שנצרך לפי מרשם והנחיית רופא לטיפול בצורך רפואי והושג באמצעותו לראשונה איזון טיפולי אצל המטופל והוא עדיין משתמש בו בהצלחה או שהוחלף ללא סיבה קלינית וללא הסכמה מדעת כהגדרתה בחוק זכויות החולה התשנ"ו - 1996 "תרופת מקור", "תכשיר מרשם" ו"תכשיר מרשם גנרי" - כהגדרתם בפקודת הרוקחים.
איסור החלפת תכשיר מרשם ללא הסכמה מדעת		(ב)	לא תחליף קופת חולים תכשיר מרשם בתכשיר רשום כזהה תחת שם מסחרי אחר, ללא הסכמה מדעת של מטופל לאחר שהוסברו למטופל ההשלכות האפשריות.
איסור התנית טיפול בהסכמה להחלפת תכשיר ייחוס		(ג)	לא תתנה קופת חולים המשך טיפול בהסכמת מטופל להחלפת תכשיר הייחוס, בתכשיר רשום זהה בין אם התכשיר החליפי רשום כתרופת מקור ובין הוא מסווג כתכשיר מרשם גנרי.
איסור שימוש בתכשיר מרשם גנרי ללא מעקב ותיעוד שינויים		(ד)	לא תאמץ קופת חולים תכשיר מרשם גנרי להנפקה למטופליה ולא תחליף תכשיר ייחוס בתכשיר זהה, ללא מעקב מודע ומתועד של המניע להחלפה ושל שינויים ברווחת ובריאות המטופל לפחות בפרק זמן זהה לנדרש להערכת יעילות טיפול תרופתי לצריכה ראשונית לפי הנחיות היצרן ובכל מקרה לא יפחת המעקב מ-90 יום.
חובת וידוא יעילות טיפולית		(ה)	בחמש השנים הראשונות לשימוש תכשיר מרשם גנרי עבור מטופליה, תקיים קופת חולים תקיים הליכי בחינה וניטור מכוונים לזיהוי שונות ביעילות הטיפולית ובתופעות הלוואי בין תרופת המקור ותכשירי המרשם הגנריים המסופקים על ידה.
חובת דיווח ממצאי יעילות טיפולית של תכשירי מרשם גנריים		(ו)	קופת החולים תדווח אחת לששה חודשים על ממצאיה לגבי כל תכשיר מרשם גנרי שהיא מספקת כל עוד היא מספקת אותו, למנהל פנקס התכשירים כהגדרתו בפקודת הרוקחים ולציבור מטופליה, בדוח מידע פתוח לשימוש מחקרי, שיוצג באופן בולט באתר האינטרנט של הקופה ובאפליקציה, ויהיה נגיש לחיפוש לפי שם התרופה.
חובת דיווח דחוף על שונות משמעותית		(ז)	מצאה הקופה חשד סביר שקיימת שונות משמעותית סטטיסטית בין התכשיר הגנרי ותרופת המקור, תדווח על כל למנהל פנקס התכשירים לאלתר, תיידע את מטופליה ותאפשר

ביעילות			להם מעבר לתרופה היעילה מבין החלופות.
חובת פרסום דוחות לציבור ומחיקת תרופות לא יעילות מפנקס התכשירים.		(ח)	שר הבריאות יפרסם אחת לשנה דוח מסכם לציבור המרכז את הדיווחים שהתקבלו לפי סעיף זה, תוך פירוט השמות המסחריים של התכשירים הרלוונטיים, ובאופן שיאפשר שקיפות ומחקר מדעי. נמצא חוסר יעילות משמעותי של תכשיר מרשם גנרי, יורה השר למנהל פנקס התכשירים על מחיקתו מהפנקס."
תוספת לסעיף 13 *לחוק זכויות החולה.*	11.		בסוף סעיף 13 לחוק זכויות החולה תשנ"ו-1996 יבוא: "(ה) שינוי בטיפול הניתן לחולה, לרבות החלפת תרופה באחרת, הוא טיפול הדורש הסכמה מדעת של המטופל לפי פרק זה. לעניין סעיף זה, החלפת תכשיר מרשם בתכשיר מרשם בעל שם מסחרי שונה, היא החלפת תרופה, גם כאשר החומר הפעיל בתכשיר החליפי זהה.
	12.		(ו) החובה לקבל הסכמה לטיפול, לרבות להחלפת טיפול, אינה מקימה לחולה זכות למימון הטיפול מעבר לחובות המימון הקבועות במפורש בחוק ו/או בסל שירותי הבריאות ו/או בשרותי הבריאות הנוספים כלל שהוא מבוטח בהם."
תוספת לסעיף 14 לחוק זכויות החולה	13.		בסוף סעיף 14(א) לחוק זכויות החולה יבוא: "ובלבד שהאמירה או ההתנהגות משקפות רצון מודע של החולה ואינן, ברירת מחדל, תוצאה של לחץ הנסיבות או ביטוי לחוסר מודעות".
תוספת לסעיף 3(ד) *לחוק בריאות ממלכתי*	14.		בסוף סעיף 3(ד) לחוק בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1994 יבוא: "שיקול דעתם של הרופא המטפל, או של הרוקח המנפיק, לא יוכפף אלא לשיקולים הנוגעים לטובת המטופל. החלפת תכשיר ייחוס, כהגדרתו בסעיף 21ה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, ללא הצדקה רפואית וללא הסכמת מטופל מודעת, לרבות בשל אילוצי מלאי והספקת תכשיר מרשם גנרי ללא מנגנון לבחינת השפעותיו ודיווח על ממצאים חריגים לציבור מהווה הפרה של חובת האיכות הטיפול הסבירה של קופת חולים לפי חוק זה"
החלפת סעיף 3(ה) לחוק בריאות ממלכתי	15.		במקום סעיף 3(ה) לחוק בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1944 יבוא: שירותי הבריאות יינתנו בכפוף לחוק זכויות החולה – תשנ"ו-1996, על בסיס הסכמה מדעת ובחינה מדעית ועובדתית של נתוני המטופל ותוך הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות הרפואית.
תוקף ותחילה	16.	(א)	תחילתו של החוק מתאריך פרסומו ברשומות. מיום זה, יחשב ניפוק של תכשיר שאינו זהה בכיתוב לשם הנקוב במרשם החלפת תכשיר אסורה לרוקח. הנפקת מרשם למטופל לתכשיר מרשם שונה מתכשיר הייחוס שלו ללא הסכמה מדעת, מעקב ודיווח

			תהווה הפרה של חובת הטיפול הסביר של קופת החולים לפי סעיף 3(ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994.
		(ב)	קופת החולים תיידע את מטופליה כי על פי החוק היא מחויבת לספק למטופלים המעוניינים בכך את תכשירי הייחוס הרלוונטיים להם, אף אם הטיפול בהם החל והסתיים טרם כניסת החוק לתוקף, ולהבטיח את אספקתו ככל שהוא זמין לרכישה בשווקים העולמיים.
		(ג)	שמו המסחרי של תכשיר מרשם או של תכשיר מרשם גנרי קיים בפנקס התכשירים ישמש שמו המסחרי למטרות הוראות סעיף 6 לחוק זה. רשאי בעל רישום של תכשיר רשום להגיש בקשה לשינוי שמו המסחרי הרשמי של התכשיר, תוך 90 יום מיום כניסת החוק לתוקף.
		(ד)	השר יתקן את התקנות הרלוונטיות לשקף את השינוי בחוק תוך 30 יום מכניסתו לתוקף. עד שיתקנן, בכל מקום שבו קיימת סתירה בין התקנות לחוק, יגבר החוק.

דברי הסבר

כללי

תרופות מרשם והשימוש בהן מהווים אתגר מורכב למטופל, לרופא ולמערכת הבריאות. כיום, המערכת מבוססת על הנחה רגולטורית לפיה תרופות גנריות הן "זהות" לתרופות מקור בהשפעתן על המטופלים. אולם, המציאות המדעית והקלינית מלמדת כי למרות הזהות בחומר הפעיל (Molecule), קיימים הבדלים בחומרי העזר, בתהליכי הייצור ובתגובת גוף האדם הספציפי לתכשירים שונים. לשינויים אלו, גם אם הם מזעריים במעבדה, עשויה להיות השפעה דרמטית על יעילות התכשיר ועצם ההחלפה בין תכשירים שיעילותם זהה, עלולה להוציא מטופל מאיזון.

כאשר ההחלפה נעשית ללא יידוע הרופא והמטופל, לעיתים תכופות מדי ועל בסיס מלאי זמין מבלי שיהיו למטופל, לרופא או לרוקח שליטה, או אפילו מודעות לשינוי, זו רשלנות מדעית ורפואית שאת היקף השלכותיה הרות האסון פוטנציאלית, אפשר רק לשער בהעדר מעקב מסודר ונתונים אפילו על היקף התופעה.

האוריינות המדעית והרפואית הנמוכה של מטופלים רבים מוסיפה בלבול וחוסר ודאות לתהליך הטיפול כשאר פציינטים מבוגרים יותר מתקשים לזהות את התרופה או לדייק את המינון בשל ריבוי החלופות.

הנחה הזהות על בסיס החומר הפעיל היא כשלעצמה בעייתית, כפי שנלמד באופן כואב בפרשת ה"אלטרוקסין" בישראל, שבה שינוי בחומר הלא-פעיל של תרופה השפיע על מצבם הרפואי של אלפי משתמשים - תוך גרימת בהלה בשל חוסר מודעות של המטופלים והמטפלים לשינוי.

הצעת חוק זו אינה שוללת את השימוש בתרופות גנריות, שהן כלי חיוני להנגשת טיפול רפואי ולהפחתת עלויות הטיפול. חלף זאת, התיקון **מסדיר את היחס המדעי לתרופות "גנריות" שאינן ואינן יכולות להיות זהות באמת למקור או לתרופות "גנריות" אחרות וקובע שזהו שינוי טיפול הדורש הסכמה ומעקב**, על בסיס חוק זכויות החולה בדרישה להתייעצות עם הרופא המטפל ו**להסכמה מדעת** של המטופל לשינוי.

באופן זה, מבקש החוק לאפשר טיפול מיטבי בחולי בישראל תוך שמירה על רצף טיפול ומניעת הפגיעה הנובעת מהחלפת טיפול שרירותית ומסוכנת.

תיקון החוק מציע הסדרה של הטיפול בתרופות גנריות בכמה היבטים:

תיקון פקודת הרוקחים (סעיפים 1, 27 ו-47א). התיקון מפריד בין ניהול רישום התרופות ואישורן, המבוסס על בחינת זמינות ביולוגית של חומר פעיל (INN) והשימוש בתרופות לטיפול באזרח ייחודי, הדורש התייחסות נפרדת לכל גרסה מסחרית ייחודית של החומר הפעיל. כדי לאפשר שקיפות ומעקב אחרי שינויים בתרופות, קובעת הצעת החוק כי כל תכשיר יזוהה ויירשם תחת שמו המסחרי הייחודי והשימוש בו במרשמים יהיה חד-חד-ערכי לשם המסחרי, לא לחומר הפעיל הרשום.

במסגרת זו, מוצע תיקון משמעותי לסעיף 27 לפקודה: ההיתר בסעיף 27 לרוקחים להמיר תרופה רשומה במקבילה "זהה" נועד לאפשר לרוקח ולמטופל גמישות. למרבה הצער, קופות החולים, שהחוק לא הסמיך אותן לשימוש זה בשום אופן, משתמשות בסעיף כדי לכפות את החלפת התרופה, באמצעות ניהול המלאי הזמין בבתי המרקחת וביטול שיקול הדעת הנדרש לטיפול מיטבי, הן של

הרוקחים, והן של הרופא המטפל שהערת "איסור ההחלפה" שלו כלל אינה רשומה במערכת הרישום האלקטרונית ללא אישור מערכת מיוחד תוך הפרה של זכות החולה לטיפול מיטבי ולמידע על המטפל בו לפי חוק זכויות החולה התשנ"ו-1996.

לאור התפתחויות אלו, וכדי למנוע החלפה אוטומטית ושרירותית של תרופות בבית המרקחת באמצעות ניהול מלאים כפי שקורה כיום, נקבע כי רוקח יכבד מרשם לפי השם המסחרי שנקב בו הרופא. במקרים בהם נרשם שם החומר הפעיל (INN) בלבד, קובע החוק **חזקה משפטית** לפיה רישום כזה מתייחס כברירת מחדל לתרופת המקור, לתרופה שנחקרה יעילותה בפועל ועל בסיסה נרשם החומר הפעיל בפנקס התכשירים.

כאמור, הצעת החוק אינה מבטלת את התרופות הגנריות והיא מכירה בחשיבותן. מנגנון זה לא נועד למנוע מרופאי קופות החולים את האפשרות לרשום תרופה גנרית מתאימה במידת הצורך - אלא להבטיח שרישום כזה נעשה במודע - על ידי הרופא ובהסכמה של המטופל, באמצעות יצירת תמריץ שלילי להמנעות מציון השם המסחרי של תרופה כדי לאפשר שימוש בחלופה גנרית שנבדקה פחות תוך מעקף מנגנוני הבדיקה והבקרה הנדרשים מדעית - וחוקית החל מכניסת החוק לתוקף.

ברירת מחדל הנוטה לתרופה המוכרת והנבדקת יותר, תתמרץ את מערכות המחשוב של קופות החולים לדייק את זהות התכשיר המבוקש ולהבטיח כי כל שימוש בתרופה חליפית יעשה מתוך מודעות ובחינה רפואית.

תיקון חוק זכויות החולה (סעיפים 13 ו-14) הצעת החוק מעגנת במפורש את היחס לתרופה גנרית כשונה מתרופת מקור כחלק מזכות המטופל לאוטונומיה על גופו. החלפת תרופה בתרופה בעלת שם מסחרי שונה, גם אם החומר הפעיל זהה, מוגדרת כ"שינוי בטיפול" המחייב הסכמה מדעת ייחודית. לא ניתן לדרוש מחולה שיסכים להחלפת תרופה כעניין שבשגרה ויש לרופא חובה לתעד את השינוי ולעקוב אחרי השפעותיו.

במקביל, ומתוך רצון לאפשר את השימוש בתרופות הגנריות ככל שאלו יעילות ומתאימות למטופל היחיד, ולשמור על איזון תקציבי, מובהר כי זכות זו אינה גוררת זכות למימון טיפול שאינו בסל, וניתנת לקופה (בחוק בריאות ממלכתי שהתיקונים בו להלן) הרשות המפורשת להציע הנחות ברכישת התרופה החליפית כדי לעודד מטופלים להתנסות בה.

תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתי (סעיפים 3, 8 ו-21ה) כדי להפוך את היחס לגנריקה למדעי יותר, מוטלת על קופות החולים חובה אקטיבית לקיים מנגנון ניטור ובחינה של השפעות התכשירים בשטח בפועל, הצעת החוק קובעת כי הקופה לא תוכל "לקנוס" מטופל המסרב להחלפה או להתנות את המשך הטיפול הרפואי בו בהסכמה למעבר לתרופה הגנרית.

המנגנון המדעי המוצע כולל חובת מעקב ודיווח למנהל פנקס התכשירים ולציבור על ממצאים חריגים או חוסר יעילות. השקיפות המדעית, הכוללת פירוט שמות מסחריים בדוחות שנתיים של משרד הבריאות, תאפשר לקהילה המדעית לבחון את איכות התרופות הגנריות לאורך זמן, ותבטיח כי תכשירים המפגינים חוסר יעילות משמעותי יוסרו מהשוק. מניעת החלפה לא מודעת של תרופות ומעקב שיאפשר החלפה מהירה של תרופה לא יעילה, עשויים להקטין את ההוצאות הרפואיות הכבדות הנובעות מהנזקים שגורמת ההחלפה הלא מבוקרת מבוססת המלאי כיום.

הבסיס התקציבי וזכות המטופל ראוי להבהיר כי הצעת חוק זו אינה תקציבית ולא נדרשת תוספת מימון בגינה לבסיס סל שירותי הבריאות. תרופות המקור הכלולות בסל תוקצבו במועד כניסתן לפי עלותן המלאה ("מחיר המקור"). כיום, המערכת נהנית מ"עודפי גנריקה" הנוצרים כאשר פג הפטנט והמחיר לקופות צונח. תקציב סל התרופות מיועד לטיפול תרופתי במטופל היחיד ולא ניתן להצדיק את הפגיעה הפוטנצאלית בו, בטענות של גלגול החיסכון חזרה לטובת הטיפול בו. סדר העדיפות להוצאה ציבורית צריך להיות שקוף ומוסכם. הפיכתם של מטופלים "לתורמים", לא מודעים, באמצעות החלפת תרופה ללא הסכמתם היא הפרה של כל סטנדרט אמת, הגינות, טיפול רפואי ראוי או קבלת החלטות דמוקרטית סבירה.

מסורה לממשלה הסמכות לשנות את סדר העדיפויות להוצאה הציבורית על בריאות. משהחליטה להשקיע את התקציב במימון תרופות - תתכבד ותעמוד בהחלטתה זו ביושר, מבלי להחליף "מאחורי גבם" של המטופלים את התרופה שנכנסה לסל התרופות בקול תרועה במקבילה "חסכונית" שיעילותה טרם הוכחה, ללא הסכמה.

הצעת החוק קובעת כי אין לעשות שימוש בחיסכון כלכלי זה כדי לכפות על המטופל מעבר לתכשיר אחר ללא הסכמתו המפורשת. בד בבד היא מאפשרת לקופה, כאמור לעיל, להעביר חלק מהחיסכון לידי המטופל במטרה לאפשר לשני הצדדים לצאת נשכרים מהשינוי במחיר לפי מידת הנוחות של המטופל והרופא להתנסות בחלופה זהה מבחינת זמינות ביולוגית.

בכל מקרה, משאבים שכבר הוקצו בבסיס התקציב עבור אותן תרופות צריכים לשמש, בראש ובראשונה, להבטחת רציפות הטיפול בתכשיר המקור או במימון מנגנוני הניטור והבטיחות הנדרשים בעת המעבר לגנריקה.

דיווח על "חוסר יעילות" ככלי מדע וחשיפת שמות מסחריים ייחודה המדעי של הצעת החוק הוא בהרחבת חובת הדיווח: לא עוד דיווח רק על "נזק" או תופעות לוואי קיצוניות, אלא חובה לנטר ולדווח על **חוסר יעילות טיפולית**. נתון זה הוא הקריטי ביותר לבחינת תכשירים גנריים, שכן הוא משקף את הפער בין ה"זהות" הכימית במעבדה לבין ה"יעילות" הקלינית בגוף המטופל. הדרישה לשקיפות מלאה הכוללת את **השמות המסחריים** של התכשירים בדוחות משרד הבריאות נועדה לאפשר לקהילה המדעית לבצע מחקרי השוואה בלתי-תלויים. מנגנון זה יבטיח כי התחרות בשוק התרופות תהיה לא רק על המחיר הנמוך ביותר, אלא גם על איכות הטיפול המוכחת בשטח.

<u>תיקון בתקנות הרוקחים (תכשירים) תשמ"ו - 1986</u>

מרשם

(א) לא ינפק אדם תכשיר לפי מרשם רופא אלא אם כן שמו המסחרי של התכשיר רשום באותו מרשם באותיות לטיניות כתובות באותיות דפוס נפרדות וקריאות או מודפסות במכונת כתיבה.

(ב) לענין תקנה זו,", הרכבו של תכשיר מרשם לא יהווה שם מסחרי וזהותו בהרכבו לתכשיר רשום אחר או רישומו כתכשיר זהה ששמו הגנרי מצוין בתוספת הראשונה לצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), התשנ"ה-1995, לא יאפשר החלפתו באחר ששמו המסחרי שונה. .